

Fecha 17/7/2026

Datos personales

Nombre completo Enrique Rezentiz Expediente PAC-000007
Edad 24 Sexo ☐ Fem ☒ Mas Edo. civil ☒ Soltero ☐ Casado Ocupación Desarrollador de software F/N 15/03/2002
Teléfono 5544332211 Dirección Av. Insurgentes Sur 1234, Col. Del Valle, CDMX

Motivos de consulta

Paciente masculino de 24 años que acude a consulta de primera vez en el área de Nutrición, referido por sobrepeso identificado en una revisión médica de rutina realizada por su empresa. Refiere que en el último año ha notado un aumento de peso gradual, de aproximadamente 6 kg, que atribuye a cambios en su rutina laboral tras iniciar un puesto de desarrollador de software, con jornadas prolongadas frente a computadora y mayor sedentarismo.

Qx o Tx previos

Sin antecedentes quirúrgicos relevantes. Niega hospitalizaciones previas, fracturas o transfusiones sanguíneas. No refiere tratamientos médicos activos ni consumo crónico de medicamentos de prescripción. Antecedente de valoración por médico general hace aproximadamente ocho meses por astenia y adinamia, con estudios de laboratorio básicos reportados como normales; no se indicó tratamiento farmacológico en ese momento.

Antecedentes patológicos heredofamiliares

Enfermedades	Madre	Padre	Aa Mat	Ao Mat	Aa Pat	Ao Pat
Diabetes Mellitus	☐	☒	☐	☐	☐	☐
Obesidad o sobrepeso	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Cáncer	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hipertensión	☐	☐	☐	☐	☐	☒
Enfermedades Renales	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Enfermedades Endocrinas	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Enfermedad Tiroidea	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Enfermedades Psiquiátricas	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Enfermedades Neurológicas	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Enfermedades Autoinmunes	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Enferm. Gastrointestinales	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otras: Abuela materna con hipotiroidismo	☐	☐	☐	☐	☐	☐

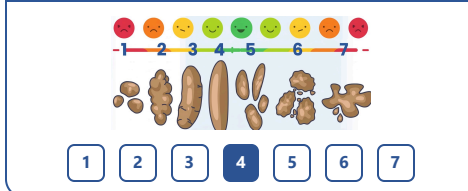
Antecedentes patológicos personales

- ☐ Diabetes Mellitus
☐ Obesidad o Sobrepeso
☐ Cáncer
☐ Hipertensión
☐ Enfermedades Renales
☐ Enfermedades Endocrinas
☐ Enfermedad Tiroidea
☐ Enfermedades Psiquiátricas
☐ Enfermedades Neurológicas
☐ Enfermedades Autoinmunes
☐ Enferm. Gastrointestinales
☐ Otras: Sin otros antecedentes personales patológicos

Sintomatología

Enfermedades	Freq./Cant.
☐ Gastritis	Niega pirosis o gastritis
☐ Colitis	Niega cuadros de colitis
☐ Reflujo gastroesofágico	Niega pirosis o reflujo
☐ Diarrea	Niega, hábito intestinal
☐ Estreñimiento	Niega, evacua a diario
☐ Vómito	Niega episodios eméticos
☐ Náuseas	Niega náuseas habituales
☐ Disfagia	Niega dificultad tragar
☐ Hiperfagia	Niega hiperfagia franca
☐ Flatulencias	Ocasionales, sin relación
☒ Distensión abdominal	Ocasional, posprandial
☐ Hiporexia	Niega, apetito conservado

Escala de Bristol



Diagnósticos médicos

Riesgo cardiometabólico incrementado por antecedente heredofamiliar materno de Diabetes Mellitus tipo 2 e Hipertensión arterial.
Sobrepeso grado I diagnosticado mediante índice de masa corporal (IMC 28.7 kg/m²) conforme a la clasificación de la OMS para adultos.
Dislipidemia mixta leve, con colesterol total límite, HDL bajo y triglicéridos elevados en el perfil bioquímico más reciente.
Adiposidad de predominio central, con circunferencia de cintura aumentada y relación cintura-cadera en riesgo cardiovascular alto.
Sin comorbilidades metabólicas establecidas al momento; se recomienda vigilancia estrecha por antecedentes heredofamiliares.

Antecedentes personales no patológicos

	Frecuencia	Cantidad
☐ Hábito tabáquico	Niega tabaquismo	No fuma actualm
☒ Consumo de alcohol	Ocasional, finde	1-2 copas/semana
☐ Consumo de drogas	Niega consumo	Nunca

Medicamentos

Medicamentos	Dosis
Complejo B	1 tableta c/24h, desayuno
Omega 3 (aceite pescado)	1000 mg oral cada 24 horas
Vitamina D3	2000 UI oral con desayuno
Paracetamol (ocasional)	500 mg oral c/8h si dolor
Loratadina (ocasional)	10 mg oral c/24h si rinitis

Ejercicio

Realiza ejercicio ☐ No ☒ Sí ☒ Aeróbico ☐ Anaeróbico
¿Cuál? Caminata en terreno plano y trote ligero los fines de semana
Frecuencia 3 veces por semana, aprox. Intensidad Moderada, esfuerzo cómodo
Tiempo 30 a 40 minutos por sesión Volumen Bajo a moderado, en aumento leve
Progresión Constante, sin incremento en las últimas semanas

Antecedentes gineco-obstétricos

G N/A de las cuales fueron: P N/A C N/A A N/A FUM N/A
Embarazo ☒ No ☐ Sí SDG N/A
Remplazo hormonal ☒ No ☐ Sí N/A
Anticonceptivos ☒ No ☐ Sí N/A

Aspectos dietéticos

Alergias alimentarias:

☒ No

☐ Sí

Cuál

No refiere alergias a medicamentos ni alimentos conocidas, incluyendo mariscos

Intolerancias alimentarias:

☒ No

☐ Sí

Cuál

No refiere intolerancias alimentarias identificadas hasta el momento de esta valoración

Alimentos de preferencia:

☐ No

☒ Sí

Cuál

Prefiere pechuga de pollo asada, verduras de hoja verde como espinaca y brócoli

Alimentos que no le agradan o no acostumbra

Refiere desagrado marcado por el hígado de res y por el pescado con alto contenido graso, así como vísceras

Comidas al día

3

Fuertes

3

Colaciones

1

¿Quién prepara sus alimentos?

Él mismo entre semana; su pareja colabora los fines de semana

Ha modificado su alimentación en los últimos 6 meses

☐ No

☒ Sí

Cómo (1 1)

Redujo de manera espontánea el consumo de refrescos y comida rápida en el últimos meses

Indicación de dieta especial/recomendada previamente

☒ No

☐ Sí

Cuál

No ha seguido dietas o planes de alimentación estructurados previos a esta valoración

Su alimentación dependiendo de su estado de ánimo

☐ No

☒ Sí

Cómo (1 1)

Aumenta la ingesta de carbohidratos simples durante periodos de estrés laboral

Uso de laxantes

☒ No

☐ Sí

Cuál

No refiere uso de laxantes ni suplementos para el tránsito intestinal

Uso de medicamentos para bajar de peso

☒ No

☐ Sí

Cuál

No ha utilizado medicamentos ni suplementos para bajar de peso previamente

Expediente cargado correctamente

Frecuencia de consumo

Verduras

5

/7 días

Fruta²

/7 días

Cereal s/g

/7 días

Pan dulce nat

/7 días

Pan dulce UP

/7 días

Galletas

1

/7 días

Leguminosas

3

/7 días

Carne de res

/7 días

Carne de cerdo

1

/7 días

Carne de pollo

4

/7 días

Pavo

1

/7 días

Pescados

2

/7 días

Mariscos

1

/7 días

Huevo

5

/7 días

Prod. anim UP

/7 días

Quesos bcos

/7 días

Quesos amr

/7 días

Embutidos

/7 días

Leche s/sab

/7 días

Yogurt s/sab

/7 días

Leche UP

/7 días

Yogurt UP

/7 días

Oleaginosas

2

/7 días

Aceites

5

/7 días

Mantequilla

2

/7 días

Margarina

1

/7 días

Refresco

3

/7 días

Agua sab UP

/7 días

Jugos nat

/7 días

Jugos UP

/7 días

Helado

1

/7 días

Nieve

/7 días

Gelatinas

1

/7 días

Aguas frutas

/7 días

Té

3

/7 días

Café

1

/7 días

Agua natural

7

/7 días

Papas fritas

2

/7 días

Garnachas com

/7 días

Garnachas fri

/7 días

Antropometría	VO	Interpretación
Talla (m)	1.75	
Peso (kg)	88	
IMC (kg/m²)	28.7	
Peso Ideal/FAO (kg)	74	
Circ. Muñeca (cm)	17	Normal
Diámetro codo (cm)	7	Complexión mediana
Circ. Brazo (cm)	33	Ligeramente aumentado
Circ. Abd (cm)	98	Aumentado
Circ. Cintura (cm)	96	
Circ. Cadera (cm)	102	
ICC	0.94	
PCB (mm)	12	
PCT (mm)	15	Normal
PCSe (mm)	20	Normal
PCSi (mm)	18	Ligeramente aumentado
% Grasa SIRI	26	Sobre rango saludable
% Grasa InBody	27	Sobre rango saludable
IMG InBody	8.5	Elevado
MLG (kg)	64	
IMLG (kg/m²)	20.9	
cAMB (cm²)	45	
MMT InBody	42	
IMEA InBody	8.9	Normal
ACT (L)	38	
Grasa Visc (L)	9	
		Ligeramente elevada

Interpretación antropométrica

Paciente masculino con sobrepeso grado I (IMC 28.7 kg/m², OMS), adiposidad de predominio central (ICC 0.94, cintura 96 cm) en riesgo cardiovascular alto. % Grasa por Siri e InBody sobre rango saludable, sin sarcopenia. Amerita intervención dirigida a reducir grasa visceral.

Signos Vitales	VO	Interpretación
T. Arterial	120/80	Normal
F. Resp (rpm)	16	Normal
F. Card (lpm)	76	Normal
Temp (°C)	36.5	Normal
SO ₂	98	Normal

Parámetros bioquímicos	VO	Interpretación
Glucosa (mg/dL)	92	Normal
Colesterol Total (mg/dL)	198	Limitrofe
HDL (mg/dL)	42	Bajo
LDL (mg/dL)	124	Limitrofe
Triglicéridos (mg/dL)	168	Elevado
Hemoglobina (g/dL)	15.2	Normal
Hematocrito (%)	45	Normal
Creatinina (mg/dL)	0.9	Normal
TSH (μU/mL)	2.8	Normal
T4 Libre (ng/dL)	1.2	Normal
Sodio (mEq/L)	140	Normal
Potasio (mEq/L)	4.2	Normal
Cloro (mEq/L)	102	Normal
AST/TGO (U/L)	22	Normal
ALT/TGP (U/L)	28	Normal
Fosfatasa alcalina (U/L)	78	Normal
Bilirrubina total (mg/dL)	0.6	Normal
Urea (mg/dL)	28	Normal
Ácido úrico (mg/dL)	5.8	Limitrofe
BUN (mg/dL)	13	Normal
Proteínas totales (g/dL)	7.1	Normal
Albumina (g/dL)	4.3	Normal
Vitamina D 25-OH (ng/mL)	22	Insuficiente
Vitamina B12 (pg/mL)	410	Normal
Ferritina (ng/mL)	65	Normal
Hierro sérico (μg/dL)	85	Normal
Insulina en ayuno (μU/mL)	14.5	Elevada
HOMA-IR	3.3	Resistencia a la insulina

Interpretación bioquímica

Glucosa normal (92 mg/dL) pese a antecedente heredo-familiar de Diabetes Mellitus tipo 2. Dislipidemia mixta leve: colesterol limitrofe, HDL bajo y triglicéridos elevados. Función renal normal. Se sugiere plan hipocalórico cardioprotector.

Solicitud de análisis

☒ Química Sanguínea

☐ EGO

☒ Biometría hemática

☐ Otro: Reevaluación en 8-12 semanas

ESA: Explorado y sin alteraciones; N/A: No aplica; PN: Preguntado y negado; ✓: Adecuado.

2

Matriz IMG/IMLG				
IMLG (kgMG/est²)	IMG disminuido (≤4 H / <7 M)	IMG adecuado (5-9 H / 7-11 M)	IMG adecuado (5-8 H / 7-11 M)	IMG elevado (≥9 H / ≥12 M)
IMLG Bajo (<17 H / <15 M)	Caquexia	Desnutrición proteico-energética	Desnutrición proteico-energética	Obesidad preclínica / clínica
IMLG Normal (17-23 H / 15-21 M)	Bajo en grasa	Normalidad	Normalidad	Obesidad preclínica / clínica
IMLG Alto (23-25 H / 21-23 M)	Atletas	Físicamente activa	Físicamente activa	Sano metabólicamente / obesidad
IMLG Muy Alto (25-28 H / 23-25 M)	Sospecha de uso de esteroides / Obesidad mórbida			
IMLG Muy Alto (>28 H / >25 M)	Diagnóstico de uso de esteroides / Obesidad mórbida			

Diagnóstico Matriz IMG/IMLG: Sano, metabólicamente funcional / persona físicamente activa según matriz IMLO/II

✓ Expediente cargado correctamente

Sistema cardiovascular-respiratorio	Ruidos cardiacos rítmicos, limpios	ESA
Sistema digestivo	Abdomen blando, depresible	ESA
Edema	Sin edema en extremidades	ESA
Extremidades	Simétricas, sin datos de varices	ESA
Ojos	Conjuntivas rosadas, sin ictericia	ESA
Pelo	Cabello con brillo, buena implant.	ESA
Cabeza	Normocéfalo, sin masas palpables	ESA
Manos y uñas	Uñas sin coloniquia, buen llenado	ESA
Boca	Mucosa oral hidratada, sin lesión	ESA
Músculos	Tono y trofismo conservados	ESA
Cuello	Cilíndrico, sin adenomegalias	ESA
Piel	Piel íntegra, elástica, hidratada	ESA
Dientes	Dentición completa, buena higiene	ESA
Garganta y deglución	Orofaringe sin hiperemia visible	ESA
Lengua	Rosada, húmeda, sin atrofia	ESA

Recordatorio de 24 horas

Fecha17/07/2026

Hora	Contenido (platillo: cantidad y alimento)
07:30	Avena cocida en leche descremada, con un plátano en rebanadas, endulzada ligeramente con canela, acompañada de un vaso de agua natural en ayuno
10:30	Una manzana mediana en trozos acompañada de diez almendras naturales sin sal, consumida a media mañana durante la jornada laboral en el trabajo
12:30	Pechuga de pollo asada a la plancha con arroz blanco, ensalada de lechuga y jitomate con poco aceite de oliva, y dos tortillas de maíz recién hechas
14:00	Agua de jamaica preparada sin azúcar añadida y una porción pequeña de papaya picada como colación ligera a media tarde antes de la siguiente comida
16:00	Yogurt natural sin azúcar añadida con granola casera preparada en casa y algunas fresas frescas picadas, consumido a media tarde como colación
17:30	Un vaso de agua natural y dos galletas integrales bajas en azúcar, consumidas como colación previa a la sesión de ejercicio vespertino programada
19:00	Licudo preparado con leche descremada, plátano maduro y avena en hojuelas, consumido inmediatamente después de la sesión de ejercicio aeróbico
20:30	Dos quesadillas de tortilla de maíz con queso panela derretido, acompañadas de salsa verde casera y un vaso de agua de jamaica sin azúcar añadida
22:00	Una taza de té de manzanilla sin azúcar consumida antes de dormir, sin ningún acompañamiento sólido adicional en esta última toma del día
23:30	Únicamente un vaso de agua natural antes de conciliar el sueño, sin ingesta sólida adicional ni bebidas azucaradas en el horario nocturno

Alimentos olvidados

• Agua

• Café / Té

• Leche

• Azúcar / Endulzante

• Jugos / Refresco

• Agua de sabor

• Sal

• Chile / Salsas

• Caramelos / Chicle

• Galletas / Pastel

• Aguacate

• Gelatina

• Nieve / Helado

• Oleaginosas

• Chocolates

• Papas / Palomitas

• Frutas

• TORTILLAS

• Aceite / Crema

• Mantequilla

Consumo de porciones					
Grupo alimentario	Porciones	Energía	Proteína	Lípidos	HCO
Verduras	3	75	6		15
Frutas	3	180			45
Cereales s/g	6	690	18		138
Leguminosas	1	120	8	1	20
POA	5	275	35	15	
Lácteo	1	110	9	6	12
Aceites s/p	4	180		20	
Aceites c/p	1	70	3	5	3
Azúcares	1	40			10
Total	25	1740	79	47	243

Distribución nutrimental actual				
Macronutriente	%	Kcal	Gramos	g/kg
Proteína	18	316	79	1.07
HCO	56	972	243	3.28
Lípidos	24	423	47	0.64
Totales	100%	1740	369	kcal/kgPA/d

Interpretación % IAN		
Energía	Dieta Adecuada	94 %
Proteína	Dieta Suficiente	86 %
HCO	Dieta Adecuada	105 %
Lípidos	Dieta Elevado	76 %

Evaluación Cualitativa	
☐ No	☒ Sí ¿Incluye todos los nutrimentos esenciales (HC, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales y agua)? → Completa
☐ No	☒ Sí ¿Los nutrimentos están en proporciones apropiadas entre sí? → Equilibrada
☐ No	☒ Sí ¿Los alimentos están libres de microorganismos patógenos, toxinas o contaminantes? → Inocua
☐ No	☒ Sí ¿No se consumen en cantidades excesivas ni contienen excesos de sodio, azúcares o grasas trans? → Equilibrada
☐ No	☒ Sí ¿Cubre los requerimientos energéticos y nutrimentales según edad, sexo, actividad física y estado fisiológico? → Suficiente
☐ No	☒ Sí ¿Incluye diferentes alimentos dentro de cada grupo alimenticio a lo largo del día o semana? → Variada
☐ No	☒ Sí ¿Evita la monotonía alimentaria? → Variada
☐ No	☒ Sí ¿Es acorde a los gustos, cultura, hábitos y disponibilidad económica? → Adecuada
☐ No	☒ Sí ¿Está ajustada a su disponibilidad económica? → Adecuada

DIAGNÓSTICOS NUTRICIOS	OBJETIVO GENERAL	
Paciente masculino de 24 años con diagnóstico nutricional de sobrepeso grado I (IMC 28.7 kg/m²) de etiología primaria por desequilibrio energético positivo, secundario a una ingesta calórica moderadamente superior al gasto energético estimado y a un patrón de actividad física insuficiente para su composición corporal actual. Se identifica adiposidad de predominio central (ICC 0.94, circunferencia de cintura 96 cm) con dislipidemia mixta leve, en presencia de antecedentes hereditarios de Diabetes Mellitus tipo 2 e Hipertensión arterial, con riesgo cardiometabólico incrementado a mediano plazo que amerita vigilancia en las próximas consultas de seguimiento.	Specific: Reducir el porcentaje de grasa corporal total y el perímetro de cintura, disminuyendo la adiposidad visceral y mejorando el perfil de lípidos séricos. Measurable: Disminuir 5 kg de peso corporal (aproximadamente 6% del peso actual) y 4 cm de circunferencia de cintura en un periodo de 6 consultas de seguimiento quincenal, con reevaluación antropométrica y bioquímica al final del proceso. Achievable: Se establece un. En formato SMART: • Specific: Definición del fenómeno • Measurable: Selección del indicador • Achievable: Evaluación de factibilidad • Relevant: Relación con el problema clínico • Time-bound: Dinámica temporal	✓ Expediente cargado correctamente Grupos de alimentos y tamaño de porciones recomendadas según el método del Plato del Bien Comer y las equivalencias del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, con énfasis en identificar fuentes ocultas Modelo transteórico del cambio de Prochaska y DiClemente, ubicando al paciente en etapa de contemplación avanzada/preparación para el cambio, dada la motivación expresada en la consulta inicial Aplicación (E-2. 2) Aplicación práctica del conteo de porciones en las tres comidas principales mediante el método del plato dividido (mitad verduras, un cuarto de cereales integrales, un cuarto de proteína magra por comida) Estrategias (C-2. 2) Establecimiento de metas SMART semanales de menor alcance dentro del objetivo general, automonitoreo mediante diario de alimentos y actividad física, y refuerzo positivo continuo en consulta

Intervención				
Indicación de Alimentos/Nutrientes	Requerimiento calórico		Cuadro dietosintético	
Aumentar el consumo de verduras a un mínimo de 5 porciones al día, priorizando hoja verde y crucíferas	☐ Ecuación predictiva Nombre: Mifflin-St Jeor		Macronutriente	%
Sustituir el refresco y bebidas azucaradas por agua natural, agua de fruta sin azúcar añadida o té	☒ Ecuación rápida Peso: 74 kg		Proteína	20
Preferir cereales integrales sobre refinados y productos de panificación con azúcares simples añadidos	Const. kcal: 25 kcal/kg/d		HCO	50
Controlar el tamaño de las porciones de grasas añadidas utilizando medidas caseras como referencia diaria	Total 1850 kcal		Lípidos	30
			Totales	100%
				1850
				385
				kcal/kgPt/d

Cálculo de porciones										
Grupo alimentario	DES	CM	COM	CV	CENA	RAC	ENERGÍA	PROT.	LÍPIDOS	HCO
Verduras	1	1	1			3	75	6		15
Frutas	1		1	1		3	180			45
Cereales s/g	1	1	2		1	5	690	18		138
Leguminosas			1			1	120	8	1	20
POA	1		2	1	1	5	275	35	15	
Lácteo	1			1		2	110	9	6	12
Aceites s/p	1	1	1	1	1	5	180		20	
Aceites c/p			1			1	70	3	5	3
Azúcares				1	1	1	40			10
Total							1850	92	62	231
% Adecuación							100	99	101	99

Menú del día				
Desayuno	CM	Comida	CV	Cena
Avena cocida en leche descremada, con un plátano en rebanadas, endulzada ligeramente con canela y acompañada de un vaso de agua natural, consumida en ayuno durante la mañana antes de salir al trabajo	Una manzana mediana cortada en trozos, acompañada de diez almendras naturales sin sal, consumida como colación a media mañana durante la jornada laboral en la oficina, entre el desayuno y la comida	Pechuga de pollo asada a la plancha, arroz blanco al vapor, ensalada de lechuga y jitomate con poco aceite de oliva, dos tortillas de maíz recién calentadas y un vaso grande de agua natural	Yogurt natural sin azúcar añadida con granola casera preparada en casa, acompañado de algunas fresas frescas picadas, consumido a media tarde como colación antes de la sesión de ejercicio	Dos quesadillas de tortilla de maíz con queso panela derretido, acompañadas de salsa verde casera recién preparada y un vaso de agua de jamaica sin azúcar añadida, consumidas temprano por la noche

Enrique Reyes — Matrícula 123654852

Nombre, matrícula y firma del alumno

Mónica Amanche — Docente responsable de Nutrición

Nombre, cédula y firma del docente responsable